

**UJIAN OSCE STATION
ANESTESIA EMERGENSI**

1	Nomor Station	2A
2	Judul station	KLL penurunan kesadaran - Intubasi EDH dengan cedera cervical
3	Alokasi waktu	17 menit
4	Tujuan station	Menilai kemampuan peserta melakukan evaluasi pra anesthesia, diagnosis dan problem aktual-potensial, rencana tindakan anestesi, keterampilan klinis, perilaku profesionalisme.
5	Kompetensi	1. Evaluasi pra anestesia 2. Diagnosis dan problem aktual – potensial 3. Rencana tindakan anestesi 4. Keterampilan klinis 5. Monitoring dan manajemen penyulit 6. Manajemen pasca anestesia 7. Komunikasi, edukasi pasien dan Perilaku profesionalisme
6	Kategori	1. Anestesia Obstetrik 2. Anestesia Bedah Saraf 3. Anestesia Regional Dan Manajemen Nyeri 4. Anestesia Bedah Toraks 5. Anestesia Pediatrik 6. Anestesia Kegawatdaruratan 7. Anestesia Urologi 8. Anestesia Untuk Penyakit Penyakit Khusus (Endokrin) 9. Anestesia Bedah Kepala Leher 10. Anestesia Bedah Rawat Jalan / Luar Kamar Bedah 11. Anestesia Pada Prosedur Invasif Minimal 12. Terapi Intensif
7	Instruksi untuk peserta	<u>SKENARIO KLINIK :</u> Seorang laki-laki berusia 38 tahun, BB 50 kg, korban kecelakaan lalu lintas, dibawa ke IGD dalam keadaan tidak sadar. <u>TUGAS:</u> 1. Lakukan initial assessment/primary survey pada pasien ini! 2. Usulkan pemeriksaan penunjang yang sesuai dengan initial assessment dan sampaikan interpretasinya! 3. Sebutkan diagnosis pada pasien ini! 4. Lakukan manajemen jalan napas pada pasien ini!
8	Instruksi untuk penguji	<u>INSTRUKSI UMUM</u> 1. Pastikan identitas peserta ujian pada kartu ujian 2. Tulislah nama dan nomor peserta ujian pada lembar penilaian! 3. Amatilah dan berilah skor (0/1/2/3) atas tugas yang dikerjakan peserta ujian serta skor Global Rating sesuai rubrik penilaian

4. Hindarilah interupsi dan/atau tindakan selain daripada yang diminta dalam instruksi penguji!
5. Berikan informasi/hasil yang dibutuhkan secara lisan/tulisan hanya apabila peserta ujian telah melakukan dan/atau mengusulkan jenis pemeriksaan yang dimaksud (perhatikan instruksi khusus)!
6. Taatilah peraturan serta etika penguji selama menjalankan tugas sebagai penguji OSCE - ATI!

INSTRUKSI KHUSUS :

1. Penguji mengamati dan menilai initial assessment yang dilakukan peserta.

Initial Assessment/ Primary Survey :

Airway: mendengkur, menjaga jalan napas, melakukan pemasangan Neck Collar brace

Breathing: Gerak dada simetris frekuensi nafas 26 x/mnt, reguler, abdominal, SpO₂ 97%, Suara napas vesikuler simetris, perkusi sonor (+/+)

Circulation: Tekanan Darah 92/53 mmHg, Nadi 55 x/mnt,

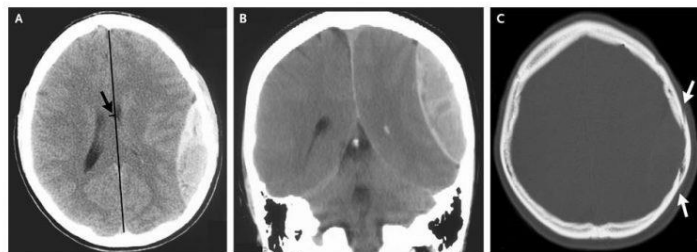
Disability: Kesadaran GCS 8 (E2V4M2); Eye : dengan rangsang nyeri mata membuka (2), Motorik : respon rangsang nyeri dgn menarik/menghindar (4), Verbal : dengan rangsang nyeri hanya keluar suara mengerang (2), Pupil anisokor 4/2 mm. RC +/-

Exposure: suhu 36,9°C. Dijumpai jejas di kepala, klavikula kiri dan dada.

2. Penguji memberikan data pemeriksaan penunjang yang diusulkan oleh peserta dan menilai usulan dan interpretasinya.

Pemeriksaan Penunjang:

1. CT Scan Kepala :



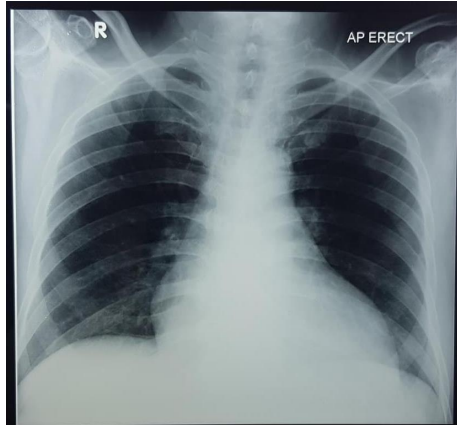
Perdarahan epidural regio temporoparietal dextra dengan midline shift dan edema serebri

2. Foto Servikal AP/Lateral:



Displacement CV C4 dan C5.

3. Foto Thorax :



Pulmo dan cor normal.

3. Penguji menilai peserta menyebutkan diagnosis dengan lengkap dan benar.

Diagnosis pasien:

1. Multiple trauma
2. Traumatic Brain Injury GCS 8 + EDH (Epidural Hematom)
3. Spinal cord injury

4. Penguji menilai manajemen jalan napas berupa intubasi dengan teknik RSI (Rapid Sequence Induction) secara tepat dan benar.

**Rencana anestesi umum melalui endotrakheal tube.
Intubasi dengan Teknik RSI**

1. Memberikan informed consent.
2. Memberikan premedikasi:
 - Metoklopramid 10 mg intravena segera mungkin dan diulang tiap 2-4 jam sampai operasi dimulai.
 - Ranitidin 50 mg intravena atau simetidin 300 mg intravena atau Famotidine 20 mg intravena
 - Obat golongan proton pump inhibitor (PPI).

		3. Memakai sarung tangan non steril. 4. Menyiapkan peralatan intubasi (STATICS): • Scope: laringoskop dan stetoskop • Tube: ETT dengan ukuran yang sesuai • Airway: Oropharyngeal airway • Tapes (plester) • Introducer (mandrin/ stylet) • Connector • Suction berfungsi baik 5. Menyiapkan obat anestesi yang diperlukan. 6. Memposisikan pasien head up position minimal 30° dengan mempertahankan imobilisasi servikal. 7. Memberikan preoksigenasi dengan O2 100% selama 3 – 5 menit. 8. Memberikan obat hipnotik – sedatif untuk induksi dengan agen intravena (propofol 2mg/kg), pelumpuh otot kerja cepat (rocuronium 1,2 mg/kgbb atau suksinilkolin). 9. Melakukan cricoid pressure (sellick's maneuver) oleh asisten. 10. Tidak memberikan ventilasi tekanan positif. 11. Melakukan intubasi setelah pelumpuh otot bekerja. 12. Mengembangkan cuff ETT. 13. Menyambungkan connector ETT dengan sirkuit anestesi. 14. Melakukan konfirmasi posisi ETT. 15. Asisten melepaskan penekanan cricoid. 16. Melakukan fiksasi ETT dengan tape/ plester.
9	Tata letak station	Model ruang IGD
10	Kebutuhan Laboran	Jumlah Laboran: 1 Tugas Laboran: Sebagai perawat, membantu peserta dalam melakukan persiapan dan tindakan intubasi.

11	Peralatan yang dibutuhkan	- Peralatan ruang IGD - Manekin intubasi dewasa - Neck collar brace - Laringoskop blade 3, 4 - ETT 7, 7.0, 7.5, 8.0 - Stetoskop - Tensimeter - Pen light - Thermometer - Sarung tangan tidak steril - Sduit berlabel - Propofol - Fentanyl - Lidokain 2% - Rocuronium - Sduit cuff - Suction cateter - Mesin suction - Oropharing no 3 dan 4 - Sungkup muka no 3,4,5 - AMBU	1 buah 1 buah @1 buah @ 2 buah 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah 1 box 1 ampul 1 ampul 1 ampul 1 ampul 1 buah 1 buah 1 buah @1 buah @1 buah 1 buah
12	Kebutuhan manekin	Manekin intubasi dengan molase jejas di bahu kanan dan kiri	
12	Penulis	Tim Item Soal OSCE ATI	
13	Referensi	1. Butterworth JF, Mackey DC, Wasnick JD. Morgan & Mikhail's Clinical Anesthesiology. 7 th Ed. New York: Mc Graw Hill. 2022 2. DAS, Difficult Intubation Guidelines, 2015	

**RUBRIK PENILAIAN OSCE
STATION ANESTESI EMERGENSI**

II. Rubrik

ASPEK YANG DINILAI	0	1	2	3	BOBOT	SKOR
1. Evaluasi pra anestesia Initial Assessment/ Primary Survey : • Airway • Breathing • Circulation • Disability • Exposure	Peserta ujian tidak melakukan initial assessment	Peserta ujian melakukan initial assessment/ primary survey namun tidak lengkap (minimal 2 poin),	Peserta ujian melakukan initial assessment/ primary survey namun tidak lengkap (≥ 3 poin),	Peserta ujian melakukan initial assessment/ primary survey secara lengkap dan benar.	2	
2. RENCANA TINDAKAN Pemeriksaan penunjang yang diusulkan oleh peserta dan menilai usulan dan interpretasinya. • CT Scan Kepala • Foto Servikal Lateral • Foto Thoraks	Peserta ujian tidak dapat mengusulkan pemeriksaan penunjang sesuai masalah klinis pasien	Peserta ujian mengusulkan minimal 1 poin pemeriksaan penunjang dan interpretasinya dengan benar, Atau Peserta ujian mengusulkan 2 poin pemeriksaan penunjang dan namun interpretasinya tidak tepat	Peserta ujian mengusulkan minimal 2 poin pemeriksaan penunjang dan interpretasinya dengan benar, Atau Peserta ujian mengusulkan 3 poin pemeriksaan penunjang dan namun interpretasinya tidak tepat	Peserta ujian mengusulkan 3 poin pemeriksaan penunjang dan interpretasinya secara lengkap dan benar.	2	
3. Diagnosis 1) Multiple trauma 2) Traumatic Brain Injury GCS 8 + EDH (Epidural Hematom) 3) Spinal cord injury	Peserta ujian tidak dapat menentukan diagnosis ATAU	Peserta ujian hanya dapat menentukan 1 diagnosis	Peserta ujian hanya dapat menentukan 2 diagnosis	Peserta ujian dapat menentukan ketiga diagnosis dengan lengkap dan benar.	2	

	Peserta ujian salah dalam menentukan diagnosis					
4. keterampilan klinis Peserta melakukan tindakan intubasi teknik RSI dengan mempertahankan posisi imobilisasi servikal.	Peserta ujian tidak melakukan tindakan intubasi teknik RSI	Peserta ujian melakukan tindakan intubasi teknik RSI dengan benar 5-10 langkah dengan mempertahankan imobilisasi servikal Atau peserta ujian tidak melakukan posisi imobilisasi cervicall.	Peserta ujian melakukan tindakan intubasi teknik RSI dengan benar >10 langkah dengan mempertahankan posisi imobilisasi servikal.	Peserta ujian melakukan tindakan intubasi teknik RSI dengan lengkap, runut dan mempertahankan posisi imobilisasi servikal.	3	
5. Perilaku profesional	Peserta ujian tidak meminta izin secara lisan dan sama sekali tidak melakukan poin berikut: 1. melakukan setiap tindakan dengan berhati-hati dan teliti sehingga tidak membahayakan pasien dan diri sendiri 2. memperhatikan kenyamanan pasien	Meminta izin secara lisan dan 1-2 poin berikut : 1. melakukan setiap tindakan dengan berhati-hati dan teliti sehingga tidak membahayakan pasien dan diri sendiri 2. memperhatikan kenyamanan pasien 3. melakukan tindakan sesuai prioritas 4. menunjukan rasa hormat kepada	Meminta izin secara lisan dan 3 poin berikut: 1. melakukan setiap tindakan dengan berhati-hati dan teliti sehingga tidak membahayakan pasien dan diri sendiri 2. memperhatikan kenyamanan pasien 3. melakukan tindakan sesuai prioritas 4. menunjukan rasa hormat kepada pasien 5. mengetahui keterbatasan dengan merujuk atau	Meminta izin secara lisan dan melakukan di bawah ini secara lengkap: 1. melakukan setiap tindakan dengan berhati-hati dan teliti sehingga tidak membahayakan pasien dan diri sendiri 2. memperhatikan kenyamanan pasien 3. melakukan tindakan sesuai prioritas 4. menunjukan rasa hormat kepada pasien	1	

	kenyamanan pasien 3.melakukan tindakan sesuai prioritas 4.menunjukkan rasa hormat kepada pasien 5.mengetahui keterbatasan dengan merujuk atau melakukan konsultasi bila diperlukan	pasien 5. mengetahui keterbatasan dengan merujuk atau melakukan konsultasi bila diperlukan	melakukan konsultasi bila diperlukan	5. mengetahui keterbatasan dengan merujuk atau melakukan konsultasi bila diperlukan		
--	---	---	--------------------------------------	---	--	--

II. Global performance

Beri tanda (✓) pada kolom yang disediakan sesuai dengan penilaian Anda secara umum terhadap kemampuan peserta ujian!

TIDAK LULUS	BORDERLINE	LULUS	SUPERIOR



Foto Servikal Lateral

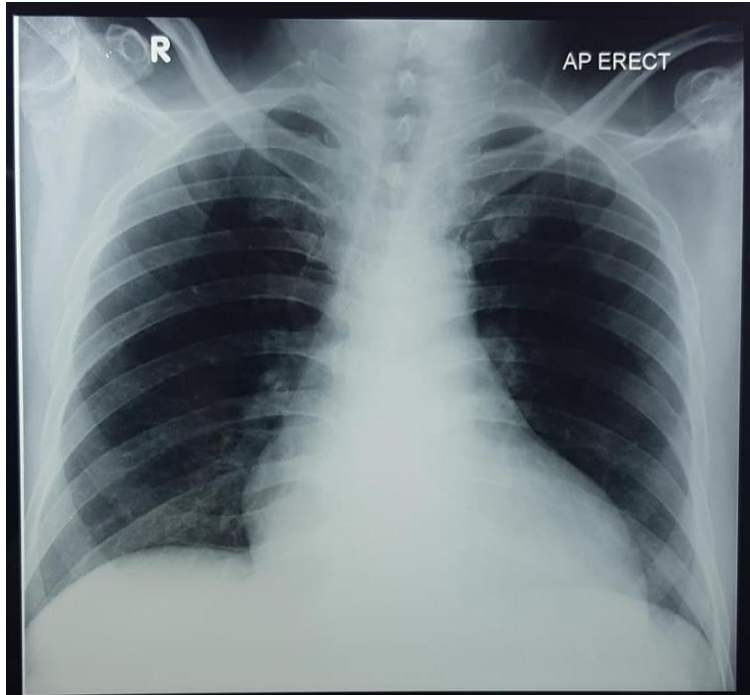


Foto Thorax

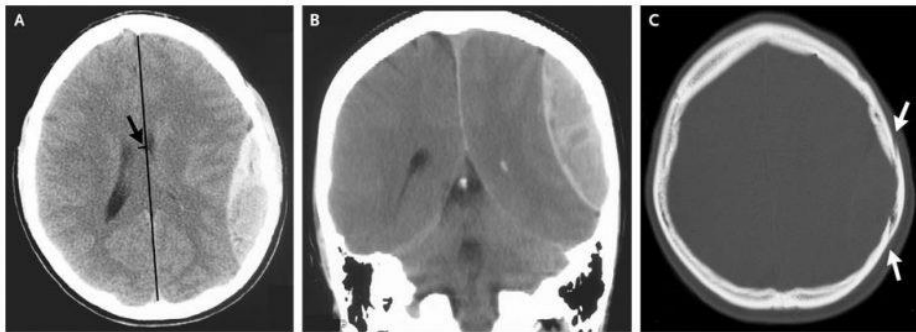


Foto CT-Scan Kepala